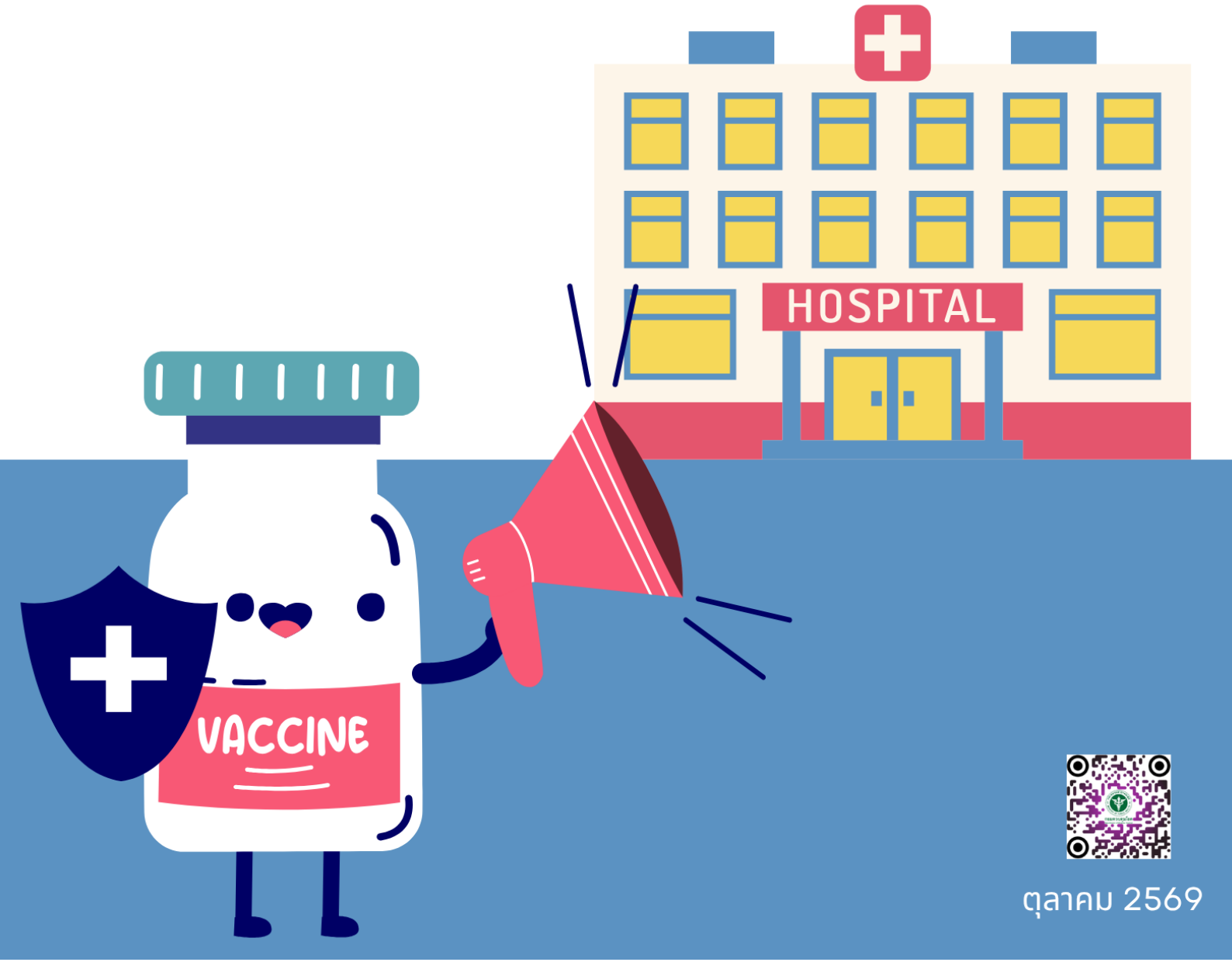
กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

คำแนะนำการให้บริการ

วัคซีนนิวโมค็อกคัสชนิดคอนจูเกต (PCV)

และการให้วัคซีนสำหรับเด็กที่มารับบริการล่าช้า

ภายใต้แผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคแห่งชาติ (NIP)



ตุลาคม 2569

คำแนะนำการให้บริการวัคซีนนิวโมค็อกคัสชนิดคอนจูเกต (PCV)
และการให้วัคซีนสำหรับเด็กที่มารับบริการล่าช้า ภายใต้แผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคแห่งชาติ (NIP)

คณะที่ปรึกษา

นายแพทย์มณเฑียร คณาสวัสดิ์	อธิบดีกรมควบคุมโรค
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงกุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ	นายกสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ที่ปรึกษาสาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทย์หญิงจุไร วงศ์สวัสดิ์	นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวนัทปรียา พงษ์สามารถ	กรรมการและประธานอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย หัวหน้าสาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
นายแพทย์ยงเจือ เหล่าศิริถาวร	ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค
เภสัชกรหญิงศิริรัตน์ เตชะธวัช	ที่ปรึกษาสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

ผู้เรียบเรียงและบรรณาธิการ

นางสาวณัฐพร ปาระมี	กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค
แพทย์หญิงปิยดา อังศุวัชรากร	กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

คำนำ

การบรรจุวัคซีนนิวโมค็อกคัสชนิดคอนจูเกต (Pneumococcal Conjugate Vaccine: PCV) เข้าสู่แผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคแห่งชาติ (National Immunization Programme: NIP) ถือเป็นก้าวสำคัญในการลดอุบัติการณ์และอัตราการเสียชีวิตจากโรคติดเชื้อนิวโมค็อกคัสแบบรุกราน (Invasive Pneumococcal Disease: IPD) โรคปอดอักเสบ และโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบในเด็กไทย ซึ่งมีสาเหตุมาจากเชื้อ *Streptococcus pneumoniae* จากฐานข้อมูล Digital Disease Surveillance (DDS) ของกองระบาดวิทยา พบว่า จำนวนผู้ป่วยและอัตราป่วยด้วยโรคปอดอักเสบไม่ระบุสาเหตุ (non-specific pathogen) และผู้ป่วยโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบไม่ระบุสาเหตุ (Non-specific pathogen) ระหว่างปี 2564 – 2567 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มเด็กอายุ 0 – 4 ปี

โดยคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ได้กำหนดตารางการฉีดวัคซีน PCV มาตรฐานแบบ 2p+1 ประกอบด้วยวัคซีนชุดเบื้องต้น (Primary series) 2 โดส (อายุ 2 และ 4 เดือน) และวัคซีนเข็มกระตุ้น (Booster) 1 โดส (อายุ 12 เดือน) ซึ่งคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้เห็นชอบให้วัคซีน PCV เป็นสิทธิประโยชน์สำหรับเด็กที่เกิดในปีงบประมาณ 2570 อย่างไรก็ตาม เพื่อรองรับกลุ่มเด็กที่มารับวัคซีนล่าช้าและเด็กที่เกิดในปี พ.ศ. 2569 ซึ่งเป็นช่วงรอยต่อของการเปลี่ยนผ่านนโยบาย กรมควบคุมโรค ร่วมกับสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย จึงได้จัดทำ **คำแนะนำการฉีดวัคซีน PCV ล่าช้า (Catch-up Vaccination)** โดยยึดหลักการบริหารจัดการ คือ การยืดถือระยะห่างที่แนะนำและระยะห่างขั้นต่ำ (Minimum Intervals) รวมทั้งการบูรณาการการบริการเข้ากับตารางนัดหมายเดิม (Minimizing Extra Visit)

กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค จึงได้จัดทำคำแนะนำฉบับนี้เพื่อให้มั่นใจว่าผู้รับบริการจะได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันโรคอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ช่วยลดความสับสนในการสื่อสารและการนัดหมาย รวมทั้งลดภาระงานของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขหน้างาน รวมทั้งเป็นการป้องกันการเสียโอกาสในการรับวัคซีน เพื่อให้เด็กได้รับภูมิคุ้มกันโรคที่เพียงพอโดยเร็วที่สุดในระดับบุคคล

กรมควบคุมโรค
สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย
ตุลาคม 2569

คำแนะนำการให้บริการวัคซีนนิวโมค็อกคัสชนิดคอนจูเกต (PCV)
(รวมกรณีเด็กที่มารับบริการล่าช้า) ภายใต้แผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคแห่งชาติ (NIP)

การบรรจุวัคซีนนิวโมค็อกคัสชนิดคอนจูเกต (Pneumococcal Conjugate Vaccine: PCV) เข้าสู่แผนงาน NIP ถือเป็นก้าวย่างสำคัญในการลดอุบัติการณ์และอัตราตายจากโรคติดเชื้อนิวโมค็อกคัสแบบรุกราน (IPD) และปอดอักเสบในเด็กไทย โดยคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ได้กำหนดตารางการฉีดมาตรฐานแบบ **2p+1** ประกอบด้วย **วัคซีนชุดเบื้องต้น (Primary series) จำนวน 2 โดส** ที่อายุ 2 และ 4 เดือน และ**วัคซีนเข็มกระตุ้น (Booster) จำนวน 1 โดส** ที่อายุ 12 เดือน ซึ่งคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้เห็นชอบให้วัคซีน PCV เป็นสิทธิประโยชน์สำหรับเด็กที่เกิดในปีงบประมาณ 2570 อย่างไรก็ตาม เพื่อรองรับประชากรเด็กที่มารับวัคซีนล่าช้า รวมถึงกลุ่มเด็กที่เกิดหลัง 1 ตุลาคม 2568 ซึ่งเป็นกลุ่มรอยต่อของการเปลี่ยนผ่านนโยบาย **กรมควบคุมโรคร่วมกับสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย** จึงได้จัดทำ **คำแนะนำการฉีดวัคซีน PCV ตามตารางมาตรฐาน รวมกรณีล่าช้า (Routine & Catch-up Vaccination)** ที่สอดคล้องกับมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก (WHO) และสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันระดับประชากรในการป้องกันโรค

1. กำหนดการการให้บริการวัคซีน PCV ตามตารางมาตรฐาน

แผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคแห่งชาติ (National Immunization Programme: NIP) ได้กำหนดตารางการฉีดมาตรฐานแบบ 2p+1 ประกอบด้วย วัคซีนชุดเบื้องต้น (Primary series) จำนวน 2 โดส และวัคซีนเข็มกระตุ้น (Booster) จำนวน 1 โดส ที่ช่วงอายุ 2, 4 และ 12 เดือน พร้อมกับวัคซีนตามแผนงานฯ ดังนี้

1) การให้บริการวัคซีน PCV โดสที่ 1

ช่วงอายุเป้าหมาย: เด็กที่อายุครบ 2 เดือน

การบริหารจัดการวัคซีนร่วม: ให้บริการฉีดพร้อมกับวัคซีน ดังนี้

1. วัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน-ตับอักเสบบี-เชื้อฮีโมฟีลัส อินฟลูเอนเซ ชนิดบี (DTwP-HB-Hib) โดสที่ 1
2. วัคซีนป้องกันโปลิโอ ชนิดฉีด (IPV) โดสที่ 1
3. วัคซีนโรตา ชนิดหยอด (Rota) โดสที่ 1

2) การให้บริการวัคซีน PCV โดสที่ 2

ช่วงอายุเป้าหมาย: เด็กที่อายุครบ 4 เดือน โดยมีระยะเวลาห่างจากโดสที่ 1 เป็นเวลา 8 สัปดาห์

การบริหารจัดการวัคซีนร่วม: ให้บริการฉีดพร้อมกับวัคซีน ดังนี้

1. วัคซีน DTwP-HB-Hib โดสที่ 2
2. วัคซีน IPV โดสที่ 2
3. วัคซีน Rota โดสที่ 2

3) การให้บริการวัคซีนโดสที่ 3 หรือเข็มกระตุ้น (Booster dose)

ช่วงอายุเป้าหมาย: เด็กที่อายุครบ 12 เดือน

การบริหารจัดการวัคซีนร่วม: ให้บริการฉีดพร้อมกับวัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจอี ชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ (LAJE) โดสที่ 1

2. การให้วัคซีน PCV กรณีรับบริการตามมาตรฐาน รวมถึงกรณีมารับล่าช้า (Catch-up Vaccination)

สำหรับเด็กที่มารับวัคซีน PCV ล่าช้าหรือไม่เคยได้รับวัคซีน PCV มาก่อน หลักการคือ **ให้พิจารณาการให้วัคซีนตามอายุของเด็กเมื่อเริ่มรับวัคซีน และระยะห่างระหว่างโดส** กรณีเด็กเคยรับวัคซีนมาก่อนแล้ว ให้นับเข็มต่อได้เลย ไม่ต้องเริ่มใหม่

2.1) เด็กที่เริ่มรับ PCV ก่อนอายุ 12 เดือน กรณีมารับวัคซีนล่าช้า แนะนำให้เว้นระยะระหว่างวัคซีนชุดเบื้องต้น (2 เข็ม) ห่าง 8 สัปดาห์ แต่สามารถเว้นระยะห่างอย่างน้อย 4 สัปดาห์ได้ หากมีเหตุผลสำคัญ เช่น เพื่อให้เด็กได้รับเข็มที่ 2 ทันเวลา หรือเพื่อเพิ่มความครอบคลุมการได้รับวัคซีน

2.2) เด็กที่เริ่มรับวัคซีน PCV เมื่ออายุ 12 – 23 เดือน ให้วัคซีน PCV 2 ครั้ง ห่างกัน**อย่างน้อย 8 สัปดาห์** โดย<u>ไม่ต้องให้เข็มกระตุ้นเพิ่มเติม</u> ตามคำแนะนำของสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย

สำหรับ**วัคซีนเข็มกระตุ้น** WHO แนะนำให้ในช่วงอายุ **9 – 18 เดือน** ตามบริบทของแผนงาน และไม่ได้กำหนดระยะห่างขั้นต่ำหรือสูงสุดระหว่างวัคซีนชุดเบื้องต้นกับเข็มกระตุ้น รายละเอียดดังตารางที่ 1 และ 2

ตารางที่ 1 ประเด็นและคำแนะนำของ WHO

ประเด็น	คำแนะนำของ WHO
อายุเริ่มให้วัคซีน PCV	เริ่มได้ตั้งแต่อายุ **6 สัปดาห์**
ระยะห่างระหว่างวัคซีนชุดเบื้องต้น	แนะนำให้ห่างกัน **≥ 8 สัปดาห์**
กรณีจำเป็นต้องลดระยะห่าง	อาจลดระยะห่างได้หากมีเหตุผลจำเป็นด้านการดำเนินงาน เช่น เพื่อให้ได้รับวัคซีนครั้งที่ 2 ทันเวลา หรือเพื่อเพิ่มความครอบคลุมของการได้รับวัคซีน โดยสามารถใช้ช่วงห่างอย่างน้อย **4 สัปดาห์**
วัคซีนเข็มกระตุ้น (Booster dose)	แนะนำให้เมื่ออายุ **9 – 18 เดือน** โดยพิจารณาตามอายุที่เริ่มฉีดเข็มแรกและตามบริบทของแผนงาน *(WHO **ไม่ได้กำหนดระยะห่างขั้นต่ำหรือระยะห่างสูงสุด** ระหว่างวัคซีนชุดเบื้องต้นกับวัคซีนเข็มกระตุ้น)

หมายเหตุ: *กรณี **เริ่มรับวัคซีน PCV เมื่ออายุ 7 – 11 เดือน** แนะนำให้เข็มกระตุ้น มีระยะห่างอย่างน้อย 8 สัปดาห์ จากเข็มที่ 2

ตารางที่ 2 คำแนะนำการให้วัคซีนตาม**อายุที่เริ่มรับวัคซีน PCV เข็มแรก** รวมกรณีล่าช้า

อายุที่เริ่มรับวัคซีน PCV เข็มแรก	วัคซีน PCV ครั้งที่ 1	วัคซีน PCV ครั้งที่ 2	วัคซีน PCV ครั้งที่ 3 (Booster)
2 เดือน	พร้อมกับวัคซีน DTP-HB-Hib1 + วัคซีน IPV1 + วัคซีน Rota1	พร้อมกับวัคซีนอายุ 4 เดือน: วัคซีน DTP-HB-Hib2 + วัคซีน IPV2 + วัคซีน Rota2	อายุ 12 เดือน พร้อมกับวัคซีน LAJE1
3 เดือน	ให้ทันที	พร้อมกับวัคซีนอายุ 4 เดือน: วัคซีน DTP-HB-Hib2 + วัคซีน IPV2 + วัคซีน Rota2 หรืออาจให้พร้อมวัคซีนอายุ 6 เดือน: วัคซีน DTP-HB-Hib3 + วัคซีน OPV3 + วัคซีน Rota3*	อายุ 12 เดือน พร้อมกับวัคซีน LAJE1
4 เดือน	พร้อมกับ วัคซีน DTP-HB-Hib2 + วัคซีน IPV2 + วัคซีน Rota2	พร้อมกับวัคซีนอายุ 6 เดือน: วัคซีน DTP-HB-Hib3 + วัคซีน OPV3 + วัคซีน Rota3*	อายุ 12 เดือน พร้อมกับวัคซีน LAJE1

อายุที่เริ่มรับวัคซีน PCV เข็มแรก	วัคซีน PCV ครั้งที่ 1	วัคซีน PCV ครั้งที่ 2	วัคซีน PCV ครั้งที่ 3 (Booster)
5 เดือน	ให้ทันที	พร้อมกับวัคซีนอายุ 6 เดือน: วัคซีน DTP-HB-Hib3 + วัคซีน OPV3 + วัคซีน Rota3*	อายุ 12 เดือน พร้อมกับวัคซีน LAJE1
6 เดือน	พร้อมกับ วัคซีน DTP-HB-Hib3 + วัคซีน OPV3 + วัคซีน Rota3*	อายุ 7 หรือ 8 เดือน หรืออาจให้พร้อมกับวัคซีน MMR1 เมื่ออายุ 9 เดือน	อายุ 12 เดือน พร้อมกับวัคซีน LAJE1
7 เดือน	ให้ทันที	อายุ 8 เดือน หรือให้พร้อมกับวัคซีน MMR1 เมื่ออายุ 9 เดือน	อายุ 12-15 เดือน
8 เดือน	ให้ทันที	พร้อมกับวัคซีน MMR1 เมื่ออายุ 9 เดือน	อายุ 12-15 เดือน
9 เดือน	พร้อมกับวัคซีน MMR1	อายุ 10 เดือน	อายุ 12-15 เดือน
10 เดือน	ให้ทันที	อายุ 11 เดือน หรือพร้อมกับวัคซีน LAJE1 เมื่ออายุ 12 เดือน	อายุ 15 เดือน
11 เดือน	ให้ทันที	พร้อมกับวัคซีน LAJE1 เมื่ออายุ 12 เดือน	อายุ 15 -18 เดือน
12 เดือน	พร้อมกับวัคซีน LAJE1	เร็วที่สุด โดยห่างจากเข็มแรก อย่างน้อย 8 สัปดาห์ (แต่ไม่ควรเกิน อายุ 18 เดือน)	-
13 เดือน	ให้ทันที		-
14 เดือน	ให้ทันที		-
15 เดือน	ให้ทันที	ห่างจากเข็มแรก อย่างน้อย 8 สัปดาห์ หรืออาจให้พร้อมกับวัคซีน DTP4 + วัคซีน OPV4 + วัคซีน MMR2 เมื่ออายุ 18 เดือน	-
16 เดือน	ให้ทันที	พร้อมกับ วัคซีน DTP4 + วัคซีน OPV4 + วัคซีน MMR2 เมื่ออายุ 18 เดือน	-
17 เดือน	ให้ทันที	เร็วที่สุด โดยห่างจากเข็มแรก อย่างน้อย 8 สัปดาห์ (แต่ไม่เกิน อายุ 2 ปี)	-
18 เดือน	พร้อมกับ วัคซีน DTP4 + วัคซีน OPV4 + วัคซีน MMR2	ห่างจากเข็มแรก อย่างน้อย 8 สัปดาห์ (แต่ไม่เกิน อายุ 2 ปี)	-
19–23 เดือน	ให้ทันที	ห่างจากเข็มแรก อย่างน้อย 8 สัปดาห์	-
24 เดือน	พิจารณาตามชนิดของวัคซีนและ ช่วงอายุที่ได้รับการรับรอง	-	-

** การให้วัคซีน Rota ให้เป็นไปตามชนิดวัคซีน จำนวนโดส และเกณฑ์อายุที่กำหนด*

หมายเหตุ หลักการพิจารณา สำหรับการให้วัคซีนล่าช้า

1) **สำหรับเด็กที่เริ่มรับ PCV ก่อนอายุ 12 เดือน** ตารางนี้ใช้ระยะห่างขั้นต่ำระหว่างวัคซีนชุดเบื้องต้น 4 สัปดาห์ เพื่อให้เด็กได้รับวัคซีนที่ขาดโดยเร็ว

2) **สำหรับเด็กที่เริ่มรับ PCV เมื่ออายุ 12–23 เดือน** ให้ PCV จำนวน 2 ครั้ง ห่างกันอย่างน้อย 8 สัปดาห์ และไม่ต้องให้เข็มกระตุ้นเพิ่มเติม

3) **สำหรับเด็กที่เริ่มรับวัคซีน PCV ตั้งแต่อายุ 24 เดือนขึ้นไป** ให้พิจารณาการให้วัคซีนตามชนิดของวัคซีนและช่วงอายุที่ได้รับการรับรอง ทั้งนี้ PCV10 (Pneumosil™) ซึ่งใช้ในแผนงานฯ ในปีปัจจุบัน ได้รับการขึ้นทะเบียนสำหรับเด็กอายุ 6 สัปดาห์ถึง 2 ปี (ก่อนครบวันเกิดปีที่ 2) จึงไม่แนะนำให้ใช้เมื่ออายุเกินช่วงอายุที่ได้รับการรับรอง สำหรับการให้วัคซีน PCV ชนิดอื่นนอกแผนงานฯ ให้พิจารณาตามข้อพิจารณาทางเทคนิคเชิงคลินิก ในหัวข้อ 3

3. ข้อพิจารณาทางเทคนิคเชิงคลินิก

1) อายุที่ได้รับการรับรองให้ใช้ของวัคซีน PCV แต่ละชนิด

- PCV10 (Synflorix™): อายุตั้งแต่ 6 สัปดาห์ ถึง 5 ปี (ก่อนครบวันเกิดปีที่ 5)
- PCV10 (Pneumosil™): อายุตั้งแต่ 6 สัปดาห์ ถึง 2 ปี (ก่อนครบวันเกิดปีที่ 2)
- PCV13 (Weuphoria™): อายุตั้งแต่ 6 สัปดาห์ ถึง 6 ปี (ก่อนครบวันเกิดปีที่ 6)
- PCV14 (Pneubevax14™): อายุตั้งแต่ 6 สัปดาห์ ขึ้นไป
- PCV13 (Prevnar13™), PCV15 (Vaxneuvance™) และ PCV20 (Prevnar20™): อายุตั้งแต่ 6 สัปดาห์ขึ้นไป

ทั้งนี้ **การเลือกใช้วัคซีนควรเป็นไปตามช่วงอายุที่ได้รับการรับรองของวัคซีนแต่ละชนิด**

2) สำหรับเด็กอายุมากกว่า 24 เดือน ถึง 5 ปี ขณะนี้ยังต้องใช้วัคซีน**นอกแผนงานฯ** โดยให้พิจารณาตามชนิดของวัคซีน ดังนี้

- PCV13, PCV15 หรือ PCV20: ให้ 1 โดส ถือว่าครบชุด
- PCV10 (Synflorix™): ให้ 2 โดส ห่างกันอย่างน้อย 8 สัปดาห์

ทั้งนี้ **ให้เลือกใช้วัคซีนที่ได้รับการรับรองให้ใช้ตามอายุของเด็ก**

3) การสลับชนิดวัคซีน (Interchangeability)

กรณีเด็กเคยได้รับวัคซีน PCV ต่างชนิดมาก่อน สามารถพิจารณาใช้วัคซีน PCV ชนิดอื่นเพื่อให้ได้รับวัคซีนครบตามตาราง โดยไม่จำเป็นต้องเริ่มชุดวัคซีนใหม่ ทั้งนี้ **ควรเลือกวัคซีนที่ได้รับการรับรองให้ใช้ตามอายุของเด็กในขณะที่มารับบริการ**

4) การให้ร่วมกับวัคซีนอื่น (Co-administration)

สามารถให้วัคซีน PCV พร้อมกับวัคซีนอื่นตามแผนงานฯ ในวันเดียวกันได้ โดยฉีดวัคซีนคนละตำแหน่ง หากต้องฉีดในตำแหน่งใกล้กันควรเว้นระยะห่างในการฉีดอย่างน้อย 1 นิ้ว

5) การให้วัคซีนกรณีมารับบริการนอกตารางนัดหมาย (Catch-up Vaccination)

กรณีเด็กมารับวัคซีน PCV ล่าช้า หรือต้องการมารับวัคซีนก่อนถึงนัดหมายตามแผนงาน NIP สามารถพิจารณาให้วัคซีน PCV ได้ เมื่อครบระยะห่างขั้นต่ำที่กำหนด (Minimum Intervals) โดยไม่จำเป็นต้องรอถึงนัดหมายครั้งถัดไป

กรณีที่สามารถให้วัคซีน PCV พร้อมกับวัคซีนอื่นตามนัดในแผนงานฯ ได้ อาจพิจารณานัดให้วัคซีนพร้อมกันเพื่อลดจำนวนครั้งที่มารับบริการ (Minimizing Extra Visit) ทั้งนี้ ควรคำนึงถึงการให้เด็กได้รับวัคซีนโดยเร็วและลดโอกาสพลาดการได้รับวัคซีน (Missed Opportunity)

หมายเหตุ: รายละเอียด ตามตารางที่ 2

6) เด็กกลุ่มเสี่ยงสูง (High-Risk Groups)

เด็กกลุ่มเสี่ยงสูง เช่น เด็กที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง ไม่มีม้าม หรือมีโรคเรื้อรัง เช่น โรคปอด โรคหัวใจ ยังคงมีสิทธิประโยชน์ในการรับวัคซีนนี้ โดย**แนะนำให้วัคซีน PCV สูตร 3P+1** โดยให้วัคซีนเบื้องต้น (Primary series) จำนวน 3 เข็ม ได้แก่ **เข็มที่ 1** เมื่ออายุ 2 เดือน **| เข็มที่ 2** เมื่ออายุ 4 เดือน **| เข็มที่ 3** เมื่ออายุ 6 เดือน และให้ **เข็มกระตุ้น (Booster) จำนวน 1 เข็ม เมื่ออายุ 12–15 เดือน** ทั้งนี้ ควรปรึกษากุมารแพทย์เพื่อประเมินประวัติการได้รับวัคซีน อายุ และภาวะเสี่ยงเป็นรายบุคคล รวมถึงพิจารณาจำนวนโดสที่เหมาะสมตามคำแนะนำสำหรับเด็กกลุ่มเสี่ยง ซึ่งอาจมีความจำเป็นต้องพิจารณาให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมค็อกคัสชนิดอื่นเพิ่มเติม (นอกเหนือจากกำหนดการตามแผนงานฯ) เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดในการป้องกันโรค

4. อาการไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีน (Adverse Events Following Immunization: AEFI)

อาการไม่พึงประสงค์ที่อาจพบภายหลังได้รับวัคซีน PCV ได้แก่ ปวด บวม หรือแดงบริเวณที่ฉีด โดยส่วนใหญ่อาการไม่รุนแรงและหายได้เองภายใน 2 – 3 วัน

บทสรุป

การให้วัคซีนในเด็กที่มารับล่าช้า (Catch up vaccination) หากสามารถบูรณาการการให้บริการวัคซีน PCV เข้ากับระบบนัดหมายตามแผนงานฯ เช่น เมื่ออายุ 9 เดือน (MMR1) หรือเมื่ออายุ 12 เดือน (LAJE1) จะช่วยเพิ่มความครอบคลุมการได้รับวัคซีน (Coverage) ให้ถึงเป้าหมายร้อยละ 90 ตามเกณฑ์ของประเทศ ทั้งนี้ หน่วยบริการควรบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ HIS ของหน่วยบริการ แล้วรายงานเข้าสู่ระบบ Health Data Center (HDC) และ MOPH PHR ให้ถูกต้อง เพื่อการประเมินความครอบคลุมการได้รับวัคซีนและประสิทธิภาพการเฝ้าระวังโรคในระยะยาว

เอกสารอ้างอิง

World Health Organization. Pneumococcal conjugate vaccines in infants and children aged <5 years: WHO position paper – September 2025. Weekly Epidemiological Record. 2025;100:411–437.